



MINISTÈRE DE LA SANTÉ
PUBLIQUE, HYGIÈNE ET
PRÉVOYANCE SOCIALE



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
**Institut National
de Santé Publique**

DIRECTION DE CONTRÔLE DES MALADIES

PROFIL ÉPIDÉMIOLOGIQUE DE LA R.D.C

Présentée lors de la réunion hebdomadaire du Comité national de coordination de la lutte contre les épidémies (CNC)

Semaine Épidémiologique 30 • Réunion du 05 Août 2026



Situation épidémiologique en RDC, SE30-2026



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Institut National
de Santé Publique

MALADIE	SEM1-S30			SEM28			SEM29			SEM30		
	Cas	Décès	Létalité	Cas	Décès	Létalité	Cas	Décès	Létalité	Cas	Décès	Létalité
CHIKUNGUNYA	5	0	0,0%	0	0	0,0%	5	0	0,0%	0	0	0,0%
CHOLERA	36405	1089	3,0%	1018	31	3,0%	1264	77	6,1%	941	38	4,0%
COQUELUCHE	1942	3	0,2%	75	0	0,0%	90	0	0,0%	51	1	2,0%
COVID-19	65	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	9	0	0,0%
DECES MATERNELS	1612	0	0,0%	57	0	0,0%	60	0	0,0%	45	0	0,0%
DIARR SANGLANTE	26608	44	0,2%	973	1	0,1%	713	0	0,0%	820	2	0,2%
DIARRHEE DHY M5	586085	882	0,2%	20247	42	0,2%	18871	18	0,1%	18604	41	0,2%
DIPHTERIE	39	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
DRACUNCULOSE	106	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	1	0	0,0%
FHA	2765	460	16,6%	202	46	22,8%	335	48	14,3%	512	65	12,7%
FIEVRE JAUNE	1298	38	2,9%	39	1	2,6%	43	1	2,3%	45	2	4,4%
FIEVRE TYPHOIDE	1511768	419	0,0%	50168	18	0,0%	45250	18	0,0%	44620	25	0,1%
GRIPPE	2133271	111	0,0%	77173	2	0,0%	74221	9	0,0%	71460	10	0,0%
IRA	3554256	576	0,0%	116761	18	0,0%	116264	6	0,0%	109389	14	0,0%
MAPI GRAVES	81	2	2,5%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
MAPI LEGERES	27054	27	0,1%	694	0	0,0%	680	0	0,0%	605	0	0,0%
MENINGITE	3409	237	7,0%	119	10	8,4%	96	6	6,3%	127	6	4,7%
MPOX	25607	286	1,1%	685	24	3,5%	615	8	1,3%	809	4	0,5%
PALUDISME CONF	10814856	8849	0,1%	351783	267	0,1%	340681	297	0,1%	320747	195	0,1%
PALUDISME SUSP	16248929	2209	0,0%	541960	307	0,1%	512995	42	0,0%	482190	24	0,0%
PESTE	2	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
PFA	2804	2	0,1%	58	0	0,0%	37	0	0,0%	60	0	0,0%
PNEUMONIE	1160999	758	0,1%	41445	34	0,1%	38843	34	0,1%	36827	41	0,1%
RAGE	229	15	6,6%	2	0	0,0%	0	0	0,0%	6	2	33,3%
ROUGEOLE	111434	1443	1,3%	3362	55	1,6%	3118	62	2,0%	2791	49	1,8%
TETANOS MATERNE	15	2	13,3%	0	0	0,0%	3	0	0,0%	0	0	0,0%
TNN	274	132	48,2%	7	2	28,6%	12	5	41,7%	6	3	50,0%

Commentaires

- Diminution de 323 cas de choléra et de la létalité entre la SE29 et SE30 ;
- Diminution de 15 décès maternels entre la SE29 et SE30 ;
- Augmentation de 177 cas de FHA et de la létalité entre SE29 et SE30 ;
- Augmentation de 31 cas et diminution du taux de létalité de la méningite entre la SE29 et SE30 ;
- Augmentation de 194 cas de Mpx et de diminution du taux de létalité entre la la SE29 et SE30 ;
- Diminution de 327 cas de la rougeole entre la la SE29 et SE30 .



EBOLA 17^{ème} épidémie: Analyse hebdomadaire SE30-2026



Provinces touchées (5)	HAUT-UELE, ITURI, NORD-KIVU, SUD-KIVU & TSHOPO
Zones de Santé touchées (49)	- Haut-Uélé (5/13) : Boma Mangbetu, Isiro, Pawa, Rungu et Wamba - Ituri (28/36) : Aru, Aungba, Bambu, Bunia, Damas, Drodoro, Gethy, Kilo, Komanda, Lita, Logo, Mambasa, Mangala, Mongbwalu, Nizi, Nyankunde, Rimba, Rwampara, Tchomia, Kambala, Nia-Nia, Fataki, Mandima, Lolwa, Boga, Ariwara, Mahagi et Adja. - Nord-Kivu (11/34) : Beni, Butembo, Goma, Kalunguta, Katwa, Kyondo, Oicha, Vuhovi, Mabalako, Masereka et Musienene. - Sud-Kivu (1/34) : Miti-Murhesa - Tshopo (4/23) : Kabondo, Lubunga, Makiso-Kisangani, Mangobo
Date de rapportage	01 Aout 2026
Date de publication	02 Aout 2026

INDICATEURS CLES — CUMUL AU 31 JUILLET 2026

CAS CONFIRMES — 5 PROVINCES 3 748 +74 nouveaux cas (Ituri 49 • N-Kivu 22 • Haut-Uélé 3)	DECES CONFIRMES • LETALITE 1 677 • (44,2 %) +36 décès (Ituri 23 • Nord-Kivu 11, Haut Uele 2)	CAS SUSPECTS DU JOUR 227 Ituri 153 • N-Kivu 66 • Haut-Uélé 4 • Sud-Kivu 4
PATIENTS EN ISOLEMENT 690 Ituri 476 • N-Kivu 181 • Haut-Uélé 31 • Tshopo 2	GUÉRIS — CUMUL 708 +15 guéris (Ituri 83 • Nord-Kivu 4)	SUIVI DES CONTACTS NATIONAL 80,1 % 13 988 / 17472 vus • Ituri 83,4 % • N-Kivu 75,1 % • H-Uélé 66,7 % • Tshopo 66,2- Sud-Kivu 100 %



EBOLA 17^{ème} épidémie: Analyse hebdomadaire SE30-2026



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
**Institut National
de Santé Publique**

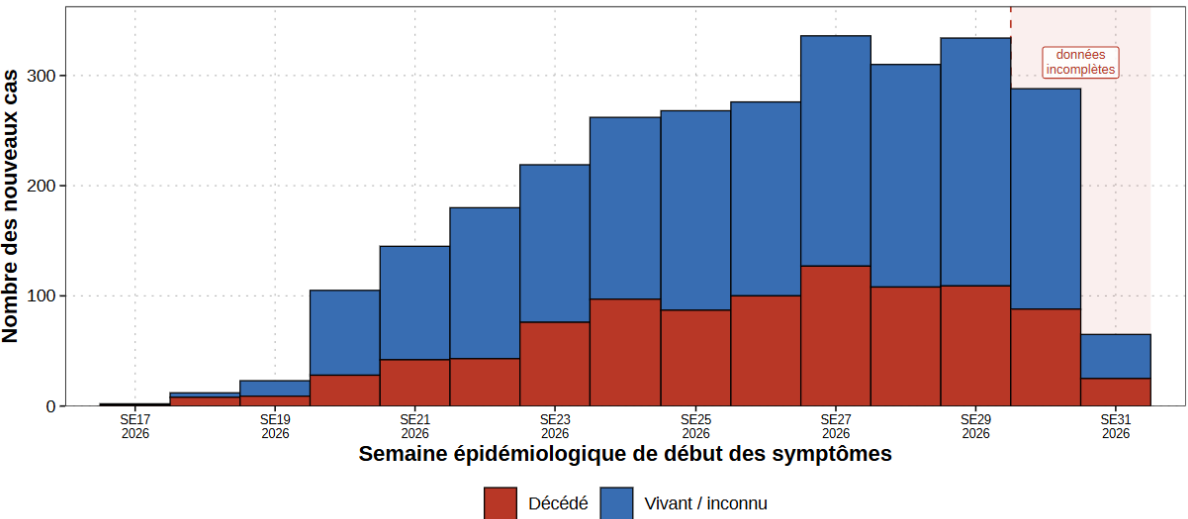
2. Evolution des cas de MVE par semaine, SE 30 2026



Tendance des cas confirmés

Cas confirmés par semaine de début des symptômes

Données du 2 août 2026 · n = 2 825 cas renseignés · délai médian début → notification = 4 j



	Médiane par semaine	Médiane par jour
Cas confirmés vivant	147	32
Cas confirmés décès	72	18
Dans l'ensemble	241	50

Source : liste linéaire DHIS2 (non réconciliée)



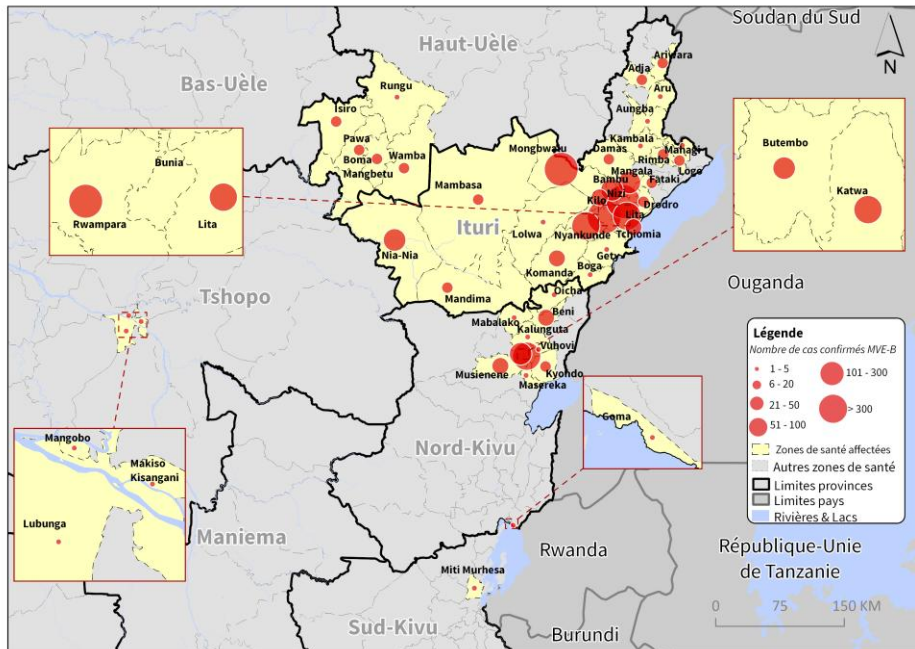
EBOLA 17^{ème} épidémie: Analyse hebdomadaire SE30-2026



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
**Institut National
de Santé Publique**

3. Distribution géographique des cas de MVE A LA SE 30 2026

Carte de la distribution spatiale globale

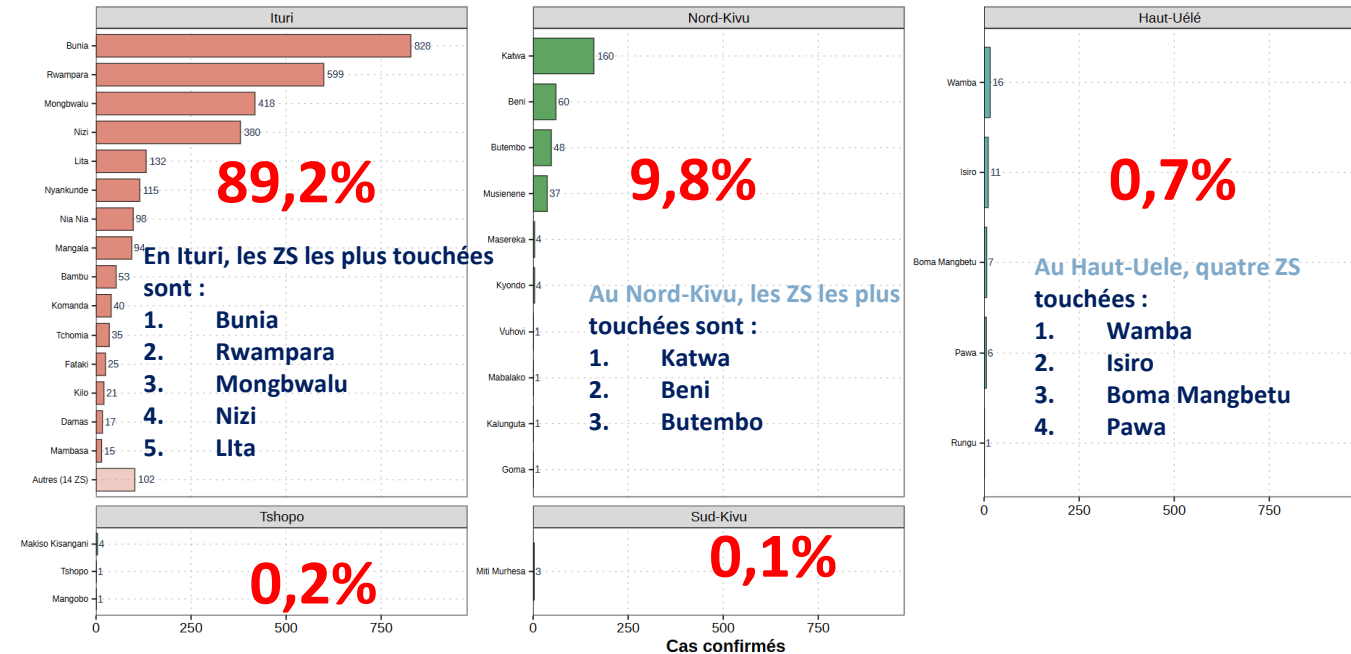


48 ZS dans 5 provinces (Haut-Uèle, Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu et Tshopo)

Distribution par province et zones des santé

Cas confirmés par zone de santé et par province, N = 3 339

Données du 2 août 2026 - 15 zones les plus touchées par province - le reste regroupé sous « Autres »



Source : liste linéaire DHIS2 (non réconciliée)
« Autres » regroupé : Ituri : Logo (14), Adja (11), Aungba (11), Drodoro (11), Ariwara (10), Lolwa (10), Rimba (6), Aru (5), Kambala (3), Mahagi (3), Gety (2), Boga (1), Rethy (1)

A la Tshopo, les ZS les plus touchées sont :

1. Makiso-Kisangani
2. Mangobo
3. Lubunga

Au Sud-Kivu, une seule ZS est touchée :

1. Miti-Murhesa



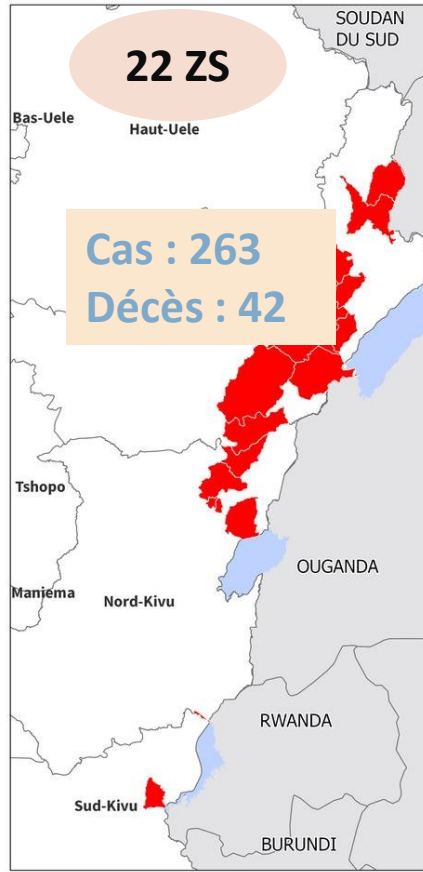
EBOLA 17^{ème} épidémie: Analyse hebdomadaire SE30-2026

4. Evolution spatiotemporelle des cas de MVE A LA SE 30 2026

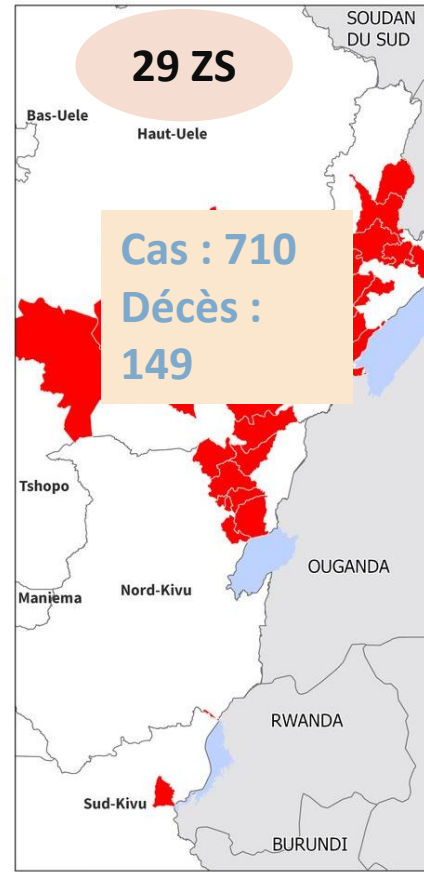
15 mai 2026



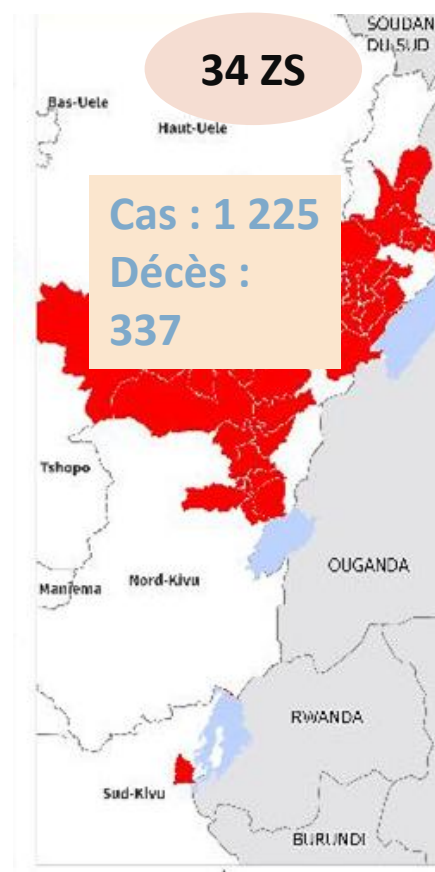
29 mai 2026



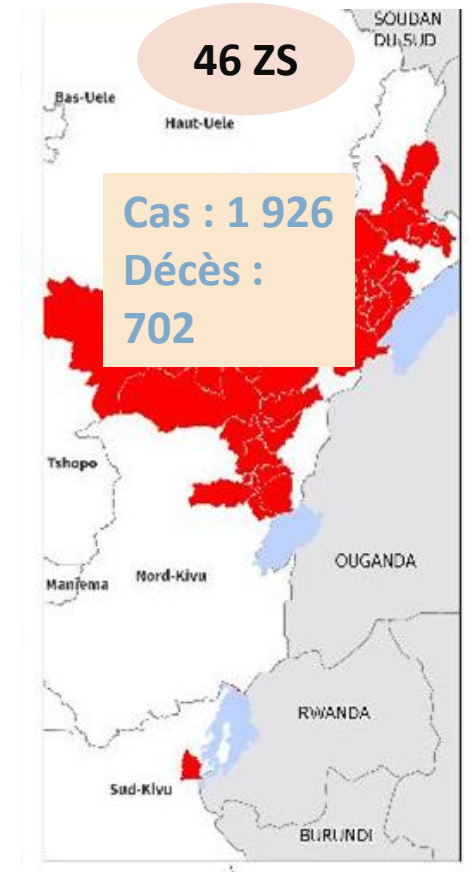
12 juin 2026



26 juin 2026



2 août 2026 = J78



Les frontières, noms et désignations utilisés sur cette carte n'impliquent en aucun cas l'expression d'une quelconque opinion de la part de l'Organisation mondiale de la Santé concernant le statut juridique d'un pays, territoire, ville ou zone, ni de ses autorités, ni quant à la délimitation de ses frontières ou limites. Source : MSPHP RDC & GRID 3 | Préparée par : Equipe HIM de Bunia | Copyright : OMS 2026

■ Zones de santé affectées
— Limites pays
— Limites provinces
— Lacs



MPOX: Analyse hebdomadaire SE30-2026



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
**Institut National
de Santé Publique**

Evolution de la situation épidémiologique Mpox SE30-2026

Cas Suspects
(IDSR)

SE30: 809
Cumul en 2026: 25698

Décès
(IDR)

SE30: 4(0,5%),
Cumul : 286(1,1%)

Cas investigués
(LL)

SE30: 57
Cumul: 6104 non à jour

Cas prélevés
(LL)

SE30: 57 Cumul: ND
Taux prélev: 7%

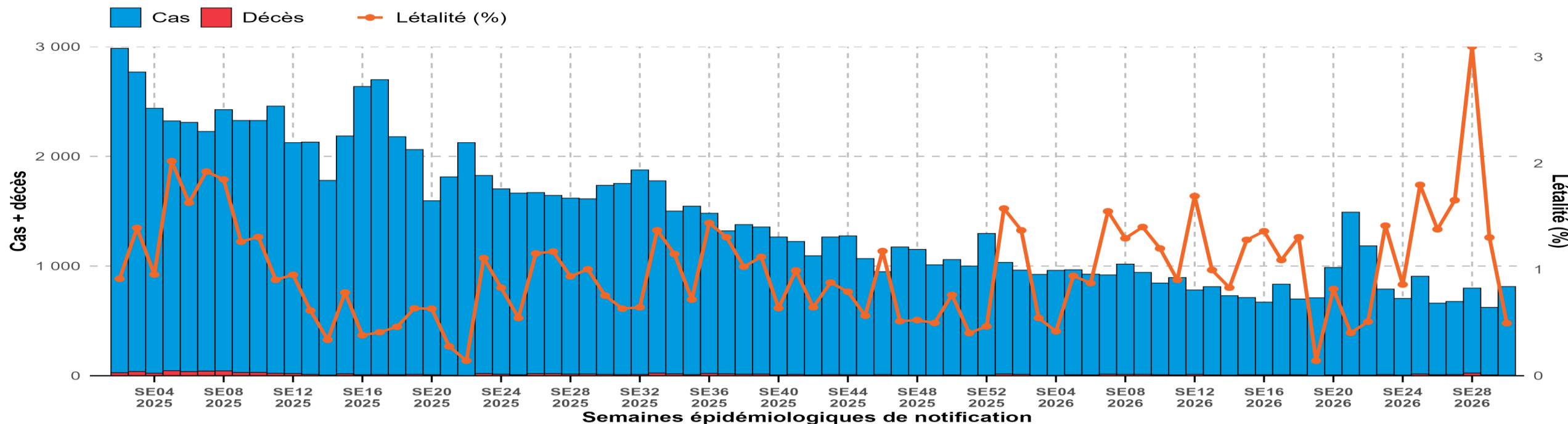
Cas avec échantillons reçus et
testés (BD Labo)

SE30 : 57, TAUX : 100%
Cumul: 4124 non à jour
TAUX GLOBAL : prêt de 16%

Cas confirmés
(BD labo)

SE30: 34
Cumul : ND
Pos: 59,6 %

Notification hebdomadaire des cas, décès et létalité – MPOX



Sources : INSP • COUSP • SGI • DHIS2

Cumul : 115 096 cas, 1 109 décès, létalité 1%
Moyenne hebdomadaire : 1 421 cas (ET = 608)
Pic : 2 958 cas (2025-SE02)
Variation : +31.5% (dernière semaine vs précédente)

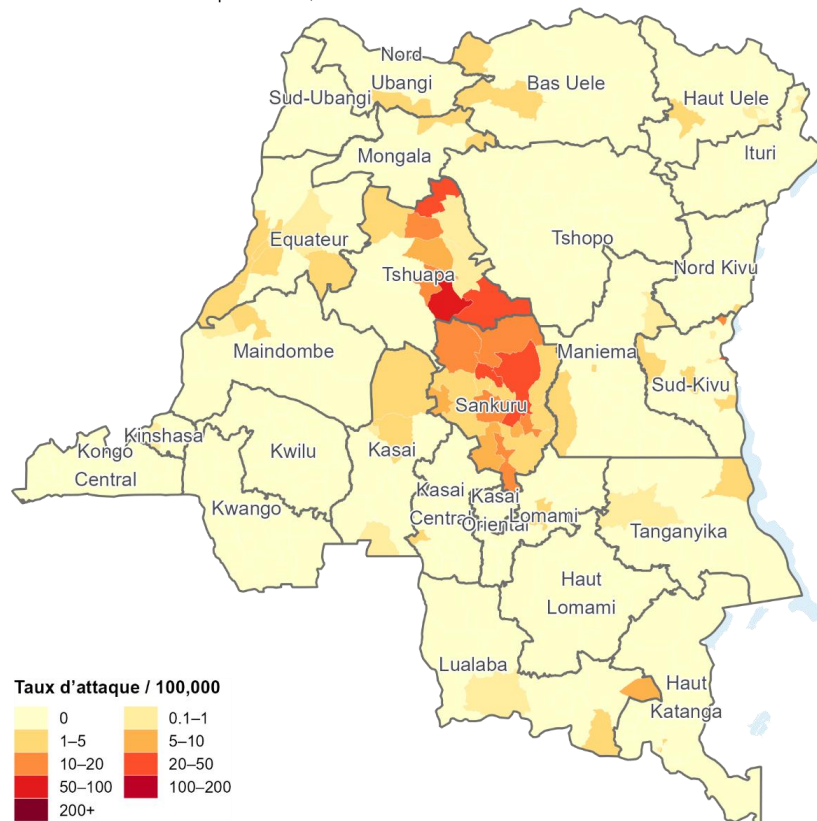


MPOX: Analyse hebdomadaire SE30-2026

ANALYSE TAUX D'ATTAQUE MPOX DE LA SE28- 30 2026

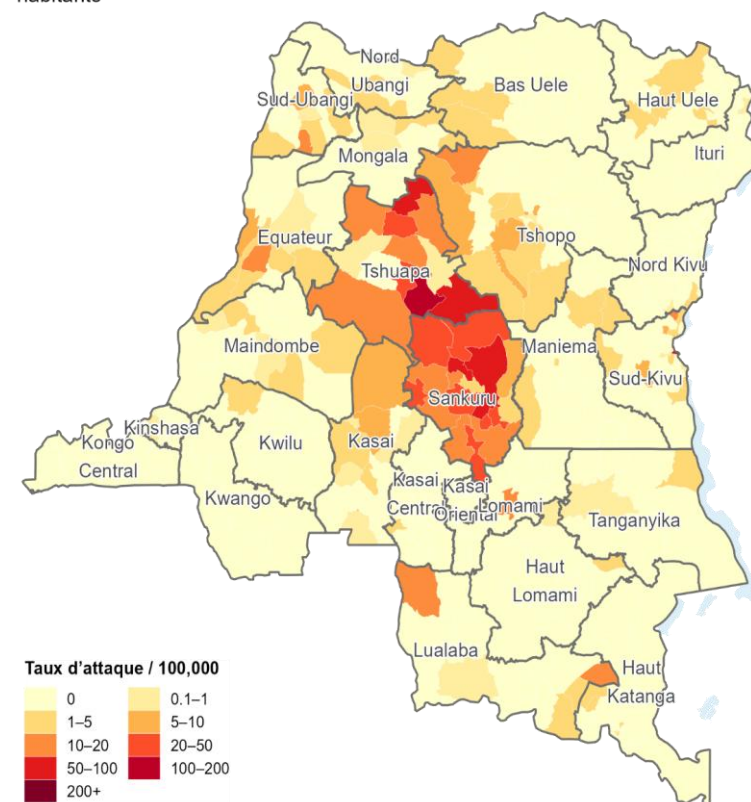
RDC : MPOX – Taux d'attaque par Zone de santé

Période : SE30-2026 | TA / 100,000 habitants



RDC : MPOX – Taux d'attaque par Zone de santé

Période : CUMUL_SE28-2026_to_SE30-2026 | TA / 100,000 habitants





Cholera: Analyse hebdomadaire SE30-2026



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Institut National
de Santé Publique



Cas Notifiés

- 1183 cas suspect (VS 1340 cas en SE29)
- Baisse de 13,3%,
- 11 provinces et 50 ZS avec au moins 1



Décès

- 34 décès (19 hospitaliers et 15 Communautaires,
- 4 décès/Jour
- létalité 1,6%

Cumul S1-S30 :

- 34230 cas suspects et 2602 confirmés (48,29%de positivité)
- Létalité est à 0,6%

Couverture Annuelle

- 18 provinces touchées
- 195 ZS.



Tendance de la situation épidémiologique du choléra S27-S30_2026

Provinces	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas SE30	Décès S30		LL	Ecart	T.L S30	TV S30-29	ZS_Cas _S30
	S27	S27	S28	S28	S29	S29		Struc t	Com m	S30	S30			
Sud-Kivu	307	13	338	13	504	22	417	12	0	198	219	2,9	-21	19
Nord-kivu	274	0	241	1	293	0	328	0	0	176	152	0,0	11	10
Kwango	43	4	59	1	113	8	157	3	11	56	101	1,9	28	3
Sud-Ubangi	73	7	112	13	270	56	155	3	3	7	148	1,9	-74	4
Tanganyika	120	3	145	3	92	5	91	1	0	67	24	1,1	-1	3
Sankuru	18	2	15	1	15	1	13	0	1	3	10	0,0	-15	3
Maindombe	28	0	28	2	20	0	8	0	0	8	0	0,0	-150	2
Haut-Katanga	40	2	26	0	21	1	6	0	0	6	0	0,0	-250	3
Kwilu	11	2	32	1	6	1	5	0	0	5	0	0,0	-20	1
Kongo Central	25	0	20	0	4	0	2	0	0	2	0	0,0	-100	1
Lualaba	1	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	0,0	-100	1
Equateur	5	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kinshasa	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	948	35	1021	35	1340	94	1183	19	15	529	654	1,6	-13,3	50

- Baisse de -13,3% entre S29 et S30.
- Quatre DPS concentrent 89,3% des cas.
- 2 provinces endémiques : > 300 cas/SE
- 2 province épidémiques : > 200 cas notifiés
- 34 décès en S30, dont 19 communautaires
- Létalité au dessus de 1%



Cholera: Analyse hebdomadaire SE30-2026



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
**Institut National
de Santé Publique**

Incidence hebdomadaire de cas suspects de choléra et taux de létalité en RDC semaine
1-52, 2024, Semaine 30-2026

S30-2024

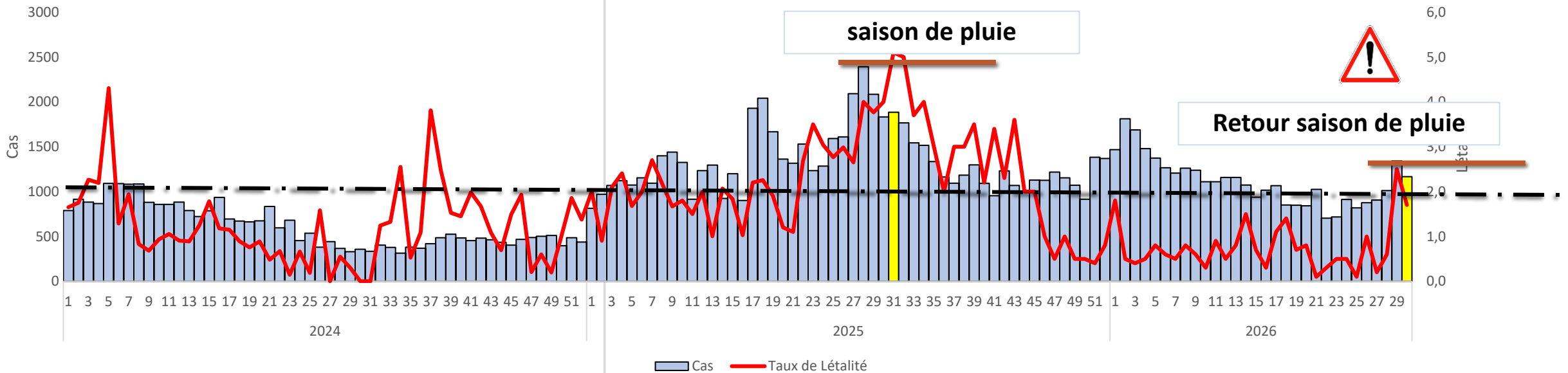
- **359 cas**
- **2 décès**
- **0,5 %T.L**
- **6 provinces**

S30-2025

- **2009 cas**
- **19 décès**
- **0,9 % T.L**
- **16 provinces**

S30-2026

- **1183 cas**
- **19 décès Hosp**
- **1,6 %T.L**
- **11 provinces**



➤ **Hausse de cas notifiés après 8 semaines consécutives depuis 2025 de moins de 1000 cas par semaine**



Cholera: Analyse hebdomadaire SE30-2026



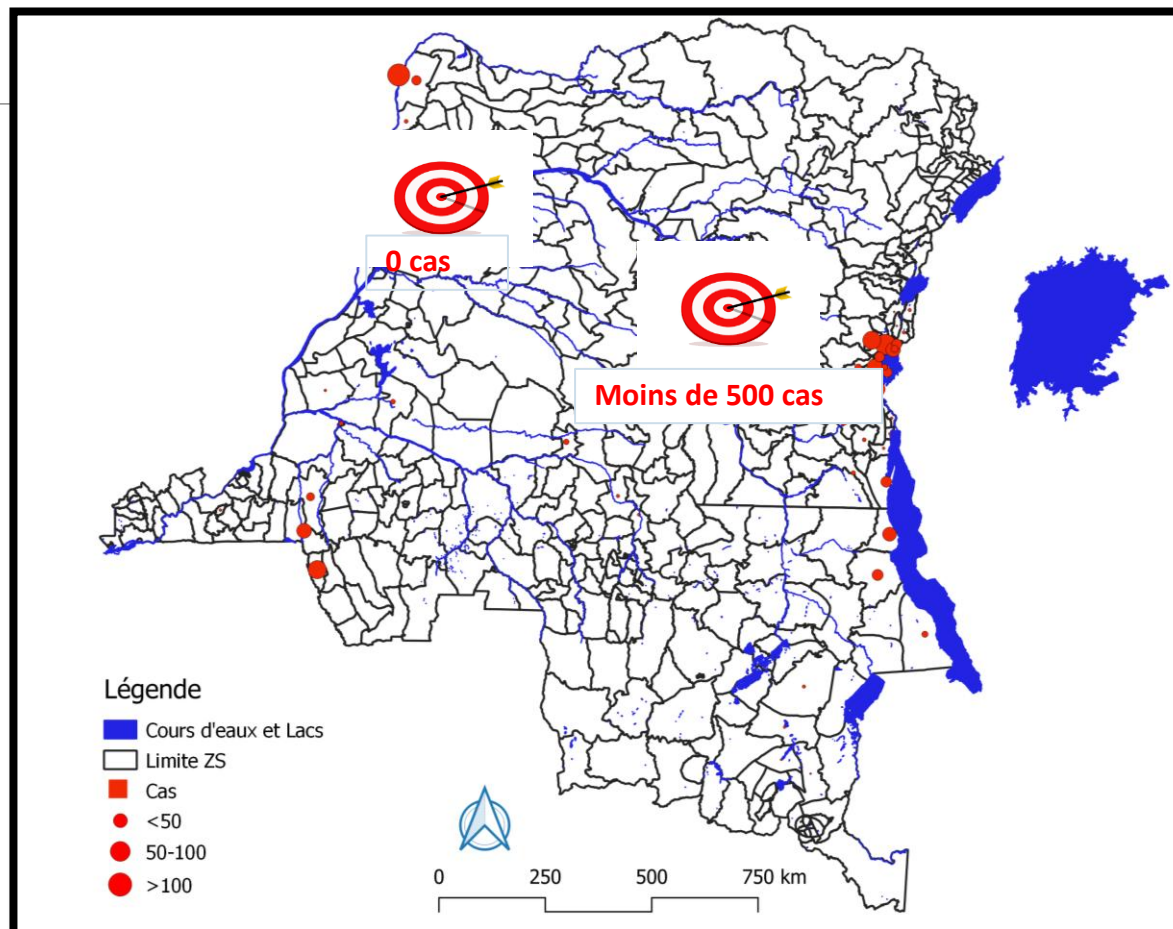
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Institut National
de Santé Publique

Répartition spatiale des cas suspects Cholera, en RDC S30, 2026

Provinces Epidémiques

DPS	Cas	Décès
Kwango	157	14
Sud Ubangi	155	6
Sankuru	13	1
Maindombe	8	0
Kwilu	5	0
Kongo C	2	0
Lualaba	1	0
Total	341	21

29% cas aux Provinces Epidémiques



Provinces Endémiques

Sud-Kivu	Cas	Décès
Sud-Kivu	417	12
Nord-kivu	328	0
Tanganyika	91	1
Haut-Katanga	6	0
Total	842	13

71% cas aux Provinces endémiques

La majorité des cas provient des **provinces endémiques** (842 cas), tandis que les **décès** se concentrent dans les provinces épidémiques (21 décès)



Polio: Analyse hebdomadaire SE30-2026



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
**Institut National
de Santé Publique**

POINTS SAILLANTS POLIO DE LA SEMAINE 31 2026

(Mise à jour au 03/08/2026)

- ❖ **14 nouveaux poliovirus à SE 31** : **11 cVDPV2** (Kabondo Dianda, Kinkondja, Tunda & Kitutu), **3 VDPV2** (Mulongo, Mukanga & Tshikula) ; un orphelin dans la province Sud Kivu.
- ❖ **18** isolats envoyés en séquençage à S31 2026
- ❖ **35** résultats de séquençage de 23 PFA, 1 contact, 1 ENV; 14 poliovirus & le reste nOPV2 Like
- ❖ **Total 96** isolats en attente des résultats de séquençage (90 isolats PFA, 3 contacts, 2 comm et 1 isolats ENV)
- ❖ **Situation 2026** : **36 poliovirus dont 30 circulants cVDPV2 (RDC-SKV1 et 5 Nlles émergences 2026 à désigner) et 6 VDPV2; 19 ZS affectées des 6 provinces : MAN 11, HLO 19, KCE 2, TAN 1, KIN 1, SKV 2;**
- ❖ **29** zones de santé sans notification sur > 6 mois (Vs **73** en 2025) dont **3** sans notification > 12 mois;
- ❖ Participation du Pays à la réunion RRT en date du 04 Aout 2026;
- ❖ Mise en œuvre de la micro planification dans la province de la Lomami



Provinces et ZS affectées par les poliovirus variants en 2025 et à SE30 2026

SE31 2026

3257 PFA et **130** collectes ENV avec échantillons au labo

36 poliovirus variants dont **30** cVDPV2 dont 1 ENV ET 4 Contacts; et **6** VDPV2

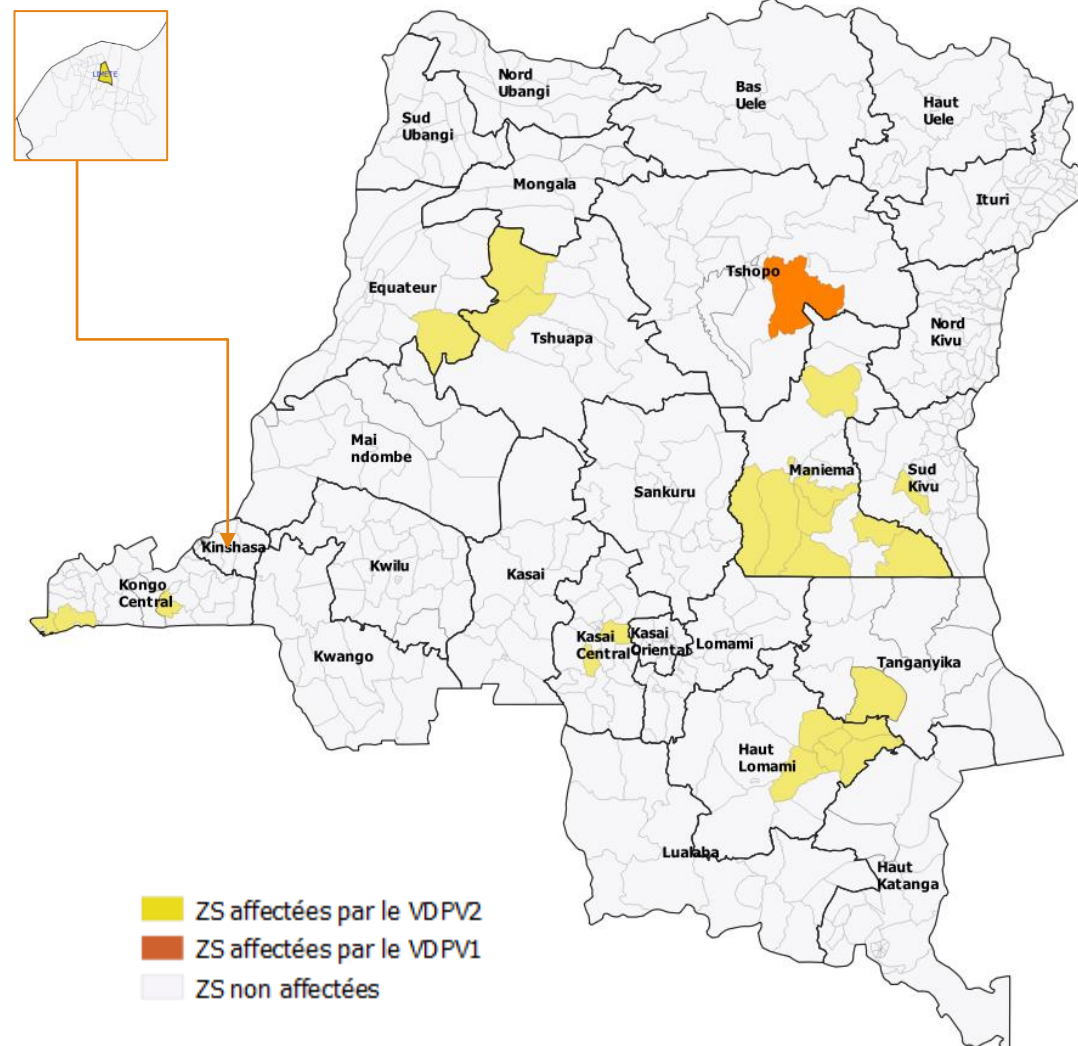
6 provinces et **18** zones de santé affectées

SE31 2025

2149 PFA et **175** collectes ENV avec échantillons au labo

2 poliovirus dont 1VDPV2 ENV ZS Limete, et un PFA de Muanda

Province	2026 (PFA)		2025 (PFA, ENV et Contacts)				
	cVDPV2 PFA	VDPV2 PFA	cVDPV1	cVDPV2 PFA	VDPV2 PFA	aVDPV2 ENV	cVDPV2 CC
Equateur					1		
Haut Lomami	16	3			1		
Kasai Central	1	1					
Kinshasa		1				1	
Kongo Central				1	2		2
Maniema	11			6			
Tshopo			1				
Tanganyika		1					
Sud Kivu	2						
Tshuapa				2			1
TOTAL RDC	30	6	1	9	4	1	3



■ ZS affectées par le VDPV2
■ ZS affectées par le VDPV1
■ ZS non affectées